

严密观察, 3 周内住院观察, 3 个月内少活动。在观察过程中应做好手术准备, 必要时随时开腹探查, 切不可在无手术条件的医疗场所贸然保守观察。

对于Ⅰ级及Ⅲ级脾破裂, 应争取行保脾手术。

对于年轻患者, 尤其是 10 岁以下儿童, 应想方设法保留脾组织, 必要时可行自体脾移植。

若患者病情危急, 出血汹涌或因伴有其他严重合并伤, 患者情况太差, 手术条件有限, 术者经验不足, 必须坚持“保命第一, 保脾第二”的原则, 迅速切除全脾以挽救患者生命。

皮下注射小剂量肝素治疗 新生儿硬肿症 28 例体会

(242400) 皖南陵县人民医院儿科

钱进 孔晓芳

我院从 1992 年 2 月至 1999 年 2 月共收治 28 例新生儿硬肿症, 采用小剂量肝素局部皮下注射治疗, 取得满意效果, 现报道如下。

全部病例符合第二届全国新生儿会议 1991 年制订的标准。其中轻度硬肿 15 例, 中度硬肿 8 例, 重度硬肿 5 例; 男性患儿 17 例, 女性患儿 11 例; 硬肿合并肺炎 12 例, 合并上呼吸道感染, 脐炎, 消化不

良等 16 例。

治疗方法: 选用肝素钙制剂, 剂量 $300\text{u/kg} \cdot \text{d}$, 每天 1 次, 在主要硬肿部位(臀部, 双下肢, 胸背部为主)皮下注射, 视病情好转而逐渐停用, 3 次及 3 次以上者输用新鲜全血或血浆。全部病例均给予复温, 补充热量及液体量, 抗感染等治疗。

治疗结果: 全部病例除 3 例合并肺炎, 1 例合并消化道及肺出血死亡外, 其余全部治愈(治愈率 85%), 治疗中无出血等副作用发生。体温恢复时间, 12 小时内复温 15 例, 12~24 小时复温 6 例, 24 小时以上复温 3 例。硬肿消退时间, 3 天以内 7 例, 3~7 天 14 例, 7 天以上 2 例; 另外注射部位硬肿消退时间明显短于非注射部位。

讨论

肝素具有较好的抗凝、抗炎抗过敏作用, 能有效地改善血液粘度, 促进血液流动, 可阻止血小板释放 5-羟色胺等介质, 与组胺、5-羟色胺、缓激肽等化学介质结合, 维持毛细血管的通透性, 阻止血浆外渗、组织水肿, 从而改善微循环, 阻断 DIC 的发病环节。及时使用肝素能有效地改善病情, 降低死亡率, 且皮下注射小剂量肝素, 吸收缓慢而均匀, 不需要实验室监护, 出血副作用少, 方法简便安全, 价格低廉, 适合在基层医院推广使用。

报刊文摘

环孢素 (CsS) 的药物相互作用 是明启

甲泼尼龙 大剂量甲泼尼龙冲击治疗排斥反应时, 能显著升高 CsS 的血药浓度。倘若 CsS 血药浓度超过有效血药浓度范围, 有可能引起 CsS 的一系列毒副作用。11 例肾移植患者, 当 CsS 血药浓度大于 400ng/ml 时, 均出现严重的 CsS 毒副作用, 表现为过度免疫抑制症状。因而在两者同时使用时, 应减少 CsS 的用量。

地尔硫草 地尔硫草与 CsS 合用于肾移植患者, 能明显地提高 CsS 的血药浓度, 减少 CsS 的用量。研究证实, 肾移植患者术后 2、3、6、12 个月用地尔硫草后, CsS 的用药剂量均较对照组减少(剂量分别较对照组减少 12.5%、13.4%、18.35 和 29.0%)。

维拉帕米 对 5 例肾移植的高血压病人进行试验后发现, 以维拉帕米 $120\sim320\text{mg/d}$ 治疗的第一周, 所有病人 CsS 血药浓度明显升高。一病人 1 周后中断维拉帕米治疗。CsS 血药浓度 1 周后降至治疗前的值。

尼卡地平 和 **硝苯地平** 9 例接受 CsS 治疗的肾移植患者的 CsS 血药浓度数据表明: 加入尼卡地平 20mg , 每日 3 次, CsS 全血谷浓度增加了 $110 \pm 92\%$ 。其中 5 例是由于不能耐受尼卡地平而改用硝苯地平的, 但用硝苯地平时无 CsS 血药浓度升高现象。

苯妥英 Keown 等对口服 CsS 且口服和静脉注射苯妥英的病人观察, 发现用妥英后引起 CsS 谷浓度迅速下降, 尽管增加了两倍 CsS 的剂量, CsS 血药浓度仍维持很低。停用苯妥英, 此相互作用缓慢消失, 1 周后, CsS 血药浓度开始回至治疗前的范围。